

川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

認知症施策推進計画

第1回 策定委員会 資料

～ アンケート結果報告 ／ 計画骨子案の協議事項 ～

令和8年 月 日（ ）

川崎町 保健福祉課

(事務局: ビズアップ公共コンサルティング株式会社)

目 次

	本日の会議について	1
第1部	アンケート結果報告	
	1. 調査の概要	3
	2. 高齢者の心身・健康の状況	3
	3. 外出・移動の状況	4
	4. 在宅介護・家族介護の状況	5
	5. 認知症に関する状況	5
	6. アンケートからみえる重点課題	6
第2部	計画骨子案の協議事項	
	1. 計画の全体構成（章立て）	7
	2. 基本理念・基本目標	7
	3. 重点施策5項目	8
	4. 認知症施策推進計画（第6章）	9
	5. 本日も協議いただきたい事項	10
	本日の進行・次回スケジュール	11

本日の会議について

第1回策定委員会では、本年6月下旬に実施した町民アンケート調査の結果をご報告するとともに、第10期計画の骨子案（章立て・基本理念・重点施策の方向性）について委員の皆様にご協議いただきます。

■ 本日の進め方

第1部	アンケート結果のご報告 （一般高齢者1,000名・認定者300名）	本資料 p3-6	25分
第2部	計画骨子案の協議（章立て・基本理念・重点施策・認知症章）	本資料 p7-10 計画素案 v1.5（別添）	40分
第3部	質疑応答・今後のスケジュール	本資料 p11	15分

■ 本計画策定の3つの方針

- ① 3層整合の原則：国基本指針・宮城県高齢者保健福祉計画と整合を取りながら策定します。
- ② 課題接続型：アンケートで把握された住民ニーズと、施策・KPIを論理的に接続します。
- ③ 認知症基本法対応：令和6年1月施行の認知症基本法を踏まえ、認知症施策を独立章として位置付けます。

●本日の最重要事項：第2部の協議事項5項目について、委員の皆様のご意見を頂戴し、計画素案 Ver.2.0 の確定に反映いたします。

第1部 アンケート結果報告

令和8年6月下旬に町から発送した「川崎町 高齢者ニーズ調査」「要支援・要介護認定者調査」の集計結果をご報告いたします。本報告は単純集計・クロス集計・自由記述の3観点で構成され、第2部の協議事項の根拠データとなります。

● 本資料の数値は集計確定値です。詳細は別添『アンケート集計分析シート』をご覧ください。

1 調査の概要

対象	65歳以上の高齢者	要支援・要介護認定を受けている方
発送数	1,000名	300名
回収数	【N=要記入】	【N=要記入】
回収率	【%=要記入】	【%=要記入】
調査期間	令和8年6月下旬～7月末	令和8年6月下旬～7月末
調査方法	郵送調査（無記名）	郵送調査（無記名）
設問数	19問（国標準16問+川崎町追加3問）	16問（国標準12問+川崎町追加4問）

川崎町追加設問では、本町固有の論点（町外医療機関の利用・町独自支援制度の認知度・町外施設の利用状況・現在の生活で最も不安なこと等）を調査しました。

2 高齢者の心身・健康の状況

■ 川崎町の高齢化（参考：保険者データ R7.6 時点）

図2-5 高齢化率比較（令和7年3月31日時点）

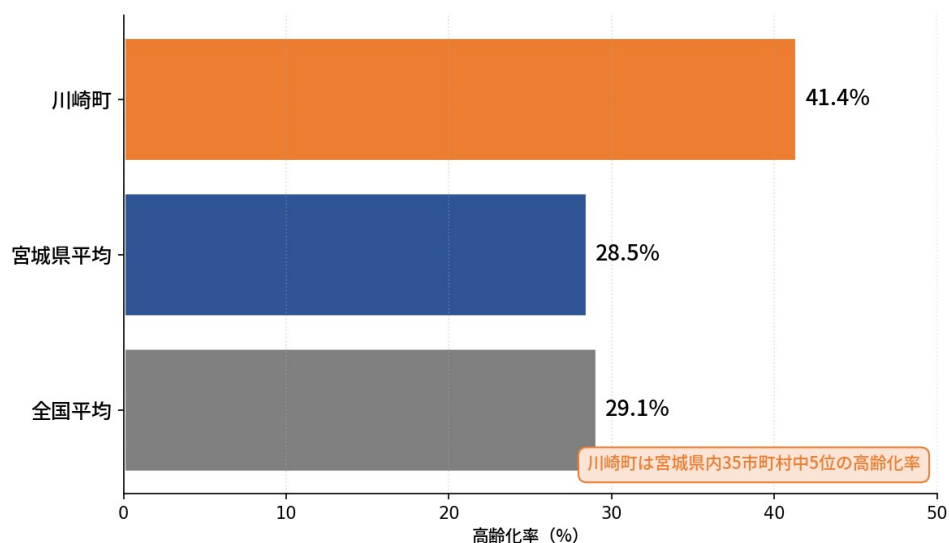


図1 高齢化率比較（川崎町：県内5位・41.4%）

川崎町の高齢化率41.4%は宮城県平均（28.5%）の約1.45倍、全国平均（29.1%）の約1.42倍に達しています。県内35市町村中5位の水準です。

■ アンケート結果（一般高齢者ニーズ調査）

健康状態が「あまり健康でない/健康でない」（Q1-1）	【%=要記入】	【人=要】	注視
週に1回も外出しない（Q1-2）	【%=要記入】	【人=要】	フレイルリスク
通いの場に「参加していない」（Q1-4）	【%=要記入】	【人=要】	社会参加リスク
特定健診を「受診していない」	【%=要記入】	【人=要】	早期発見機会の損失

出典：川崎町第10期計画策定に係るアンケート調査（令和8年6月実施）

「通いの場参加していない」「外出頻度週1回未満」の層は、フレイル進行・要介護化のリスクが相対的に高く、第10期計画では介護予防事業の対象拡大が重要となります。

3 外出・移動の状況（川崎町固有論点）

川崎町では、令和7年3月に高齢者外出タクシー助成事業が終了し、現在は社協・NPOによる福祉移送サービス、デマンドバス、町民バスの3層構造に移行しています。本調査では、住民の交通手段・移動困難の実態と、町移動支援3制度の認知度を把握しました。

■ 主な交通手段と移動の困りごと

交通手段1位「自家用車（自分で運転）」	【%=要記入】	65-74歳に集中
交通手段2位「家族の車に同乗」	【%=要記入】	75歳以上に多い
外出困難「公共交通機関が少ない」（Q2-1）	【%=要記入】	中山間部住民で高い
外出困難「運転が不安・できない」	【%=要記入】	80歳以上で増加

■ 町の移動支援3制度の認知度（Q2-2 川崎町追加設問）

町民バス	【%=要】	地域振興課	【評価=要】
デマンドバス	【%=要】	町民生活課	【評価=要】
社協・NPO福祉移送サービス	【%=要】	社協・NPO	【評価=要】
いずれも知らない	【%=要】	—	周知強化必要

「いずれの制度も知らない」層が一定数いる場合、3制度の住民周知強化と利用情報の一元化が課題となります。所管が分かれている現状の整理が必要です。

4 在宅介護・家族介護の状況（認定者調査）

要支援・要介護認定者300名へのアンケートから、サービス利用・家族介護・町外施設利用の実態を把握しました。

サービス満足度「あまり満足でない/不満」（Q1-2）	【%=要記入】	第5章 5-4
介護者の負担感「とても負担」（Q2-2）	【%=要記入】	第5章 5-3
介護のため「仕事を辞めた・転職した」（Q2-3）	【%=要記入】	第5章 5-3 介護離職防止
町外施設の利用「あり」（K-1 川崎町追加）	【%=要記入】	第7章 7-1 / 第5章 5-4
町外施設の所在地内訳（K-2 川崎町追加）	【柴田/大河原/仙台等=要】	広域連携の検討
現在の最大の不安「介護者の負担」（K-4 川崎町追加）	【%=要記入】	第5章 5-3 第6章

住所地特例該当者24名（R7.6時点）の所在地内訳をアンケートで把握することで、町外施設依存の実態と広域連携の必要性が明確になります。

5 認知症に関する状況（基本法対応の根拠データ）

令和6年1月施行の認知症基本法第14条に基づき、市町村認知症施策推進計画の策定が努力義務化されました。アンケートで認知症に関する町民の不安・意識を把握し、第6章独立章の根拠データとします。

認知症の不安「自分自身になることが不安」（Q3-1）	【%=要記入】	6-3 KPI「認知症本人と家族の生活満足度」
認知症の不安「家族になることが不安」	【%=要記入】	家族支援 J-2 チームオレンジ
認知症の相談窓口「知っている窓口はない」（Q3-2）	【%=要記入】	J-4 早期発見・体制強化
認知症サポーター養成講座を「受講したい」（Q3-3）	【%=要記入】	J-1 サポーター拡大
【認定者調査】認知症の人としての社会参加希望	【%=要記入】	J-3 本人ミーティング新設

「相談窓口を知らない」層が多い場合、地域包括支援センター・認知症カフェ「喫茶みかん」・国保川崎病院の周知強化が重点課題となります。

6 アンケートからみえる重点課題

アンケート結果と本町固有の状況（高齢化率 41.4%・移動支援 3 層構造移行・住所地特例 24 人・認知症基本法対応等）を踏まえ、第 10 期計画で対応すべき重点課題を以下のとおり整理しました。これらの課題は第 2 部の基本目標・重点施策の根拠となります。

課題① 認知症対応の総合的推進（基本法対応） 認知症の相談窓口の認知度が低く、町民の不安が大きい。基本法対応として独立章化し、サポーター拡大・チームオレンジ整備・本人ミーティング新設等を重点化する。

課題② 移動支援 3 層構造の確立と住民周知 タクシー助成終了後の 3 制度（町民バス・デマンドバス・社協 NPO 移送）の認知度が低く、所管が分散している。利用情報の一元化と周知強化が急務。

課題③ 在宅介護継続の支援強化（家族介護者・8050 問題対応） 介護者負担が大きく、介護離職も発生。未婚の子と高齢親の同居（8050 問題）、配偶者間の老老介護への対応として、家族介護者支援とレスパイト体制を強化。

課題④ 施設サービスの広域連携と人材確保 住所地特例 24 人（R7.6）が示すとおり町外施設依存が常態化。広域連携と町外施設情報の整理、深刻化する介護人材不足への対応が必要。

課題⑤ 町外医療機関との広域医療連携 みやぎ県南中核病院・刈田総合病院等への通院・連携が日常化。在宅医療と広域医療をつなぐ体制整備が課題。

第2部 計画骨子案の協議事項

第1部で把握した重点課題と本町固有の状況を踏まえ、第10期計画の骨子案（章立て・基本理念・重点施策・認知症章）の方向性を以下に提示します。委員の皆様には、各協議事項についてご意見を頂戴したく存じます。

● 本骨子案は計画素案 v1.5（別添 43 頁）を委員会向けに集約したものです。詳細は別添素案をご参照ください。

1 計画の全体構成（章立て）

第9期計画の体系を基本的に踏襲しつつ、認知症基本法対応として基本目標6（認知症施策の総合的推進）を新設し、第6章として独立章化します。

1	計画の策定にあたって	3つの基本方針（3層整合・課題接続・基本法対応）を新設	—
2	川崎町の高齢者を取り巻く現状	図表6種を新規埋込・高齢化率41.4%等	—
3	第9期計画の取組実績と評価	6目標別の実績整理（独立章化された認知症含む）	—
4	計画の基本理念と基本目標	基本目標6（認知症）を新設、計6目標	—
5	施策の展開（基本目標1～5）	基本目標1～5に対応した施策・主な事業・KPI	課題②③④⑤
6	認知症施策推進計画（独立章）	基本法対応の新設・7基本的施策・重点5本柱	課題①
7	介護保険サービス見込量と保険料	見込量6ステップ・保険料8ステップ・3パターン試算	—
8	計画の推進体制と評価	PDCAサイクル・8章独立化	—

2 基本理念・基本目標

■ 基本理念（第9期踏襲）

住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

■ サブタイトル（第10期で新たに付加・案）

～認知症になっても誰もが自分らしく暮らせる地域共生社会の実現～

■ 基本目標（第10期・全6目標）

1	健康づくりと介護予防の推進	—	第5章 5-1	継承（ユニバーサルサポーター強化）
2	高齢者が安心して暮らせるまちづくり	課題②	第5章 5-2	継承（移動支援3層構造を新規）
3	在宅生活継続の支援	課題③⑤	第5章 5-3	継承（家族介護者支援強化）
4	介護サービスの質確保と提供体制	課題④	第5章 5-4	継承（広域連携の明示）
5	地域包括ケアシステムの深化	—	第5章 5-5	継承（包括センター体制強化）
6	認知症施策の総合的推進	課題①	第6章 独立	新設（基本法対応）

3 重点施策5項目（課題接続型）

第10期計画では、アンケートから把握した5重点課題に対応する重点施策を以下のとおり整理します。各施策は「住民ニーズ→施策→KPI」の3層構造で設計しています。

J-A	認知症施策の総合的推進	認知症相談窓口を知らない層が一定数。基本法対応必要	サポーター拡大・チームオレンジ整備・本人ミーティング新設・初期集中支援強化	3層 KPI 設定
J-B	移動支援3層構造の確立	タクシー助成終了後の3制度の認知度低い・所管分散	社協NPO移送・デマンドバス・町民バスの整理・住民周知の一元化	認知度70%
J-C	家族介護者支援・介護離職防止	介護者負担大・介護離職発生・8050問題	家族介護教室・レスパイト体制・介護離職防止支援	介護離職率減
J-D	施設広域連携・人材確保	住所地特例24人(R7.6)・町外依存・人材不足	町外施設情報整理・住所地特例所在自治体把握・人材確保支援	町外施設情報整備
J-E	広域医療連携の体制整備	町外医療機関への通院常態化	みやぎ県南中核病院・刈田総合病院との連携・国保川崎病院ハブ化	連携件数増

4 認知症施策推進計画（第6章独立章）

認知症基本法第 14 条に基づき、市町村認知症施策推進計画を本計画第 6 章として独立章化します。本章は基本法第 15 条～21 条の 7 基本的施策に対応した町施策体系で構成します。

重点施策 5 本柱

J-1	認知症サポーターの拡大と質向上	継続（累計 550 名・キャラバンメイト 73 名）	企業・学校サポーター拡大、ステップアップ研修
J-2	チームオレンジの整備（新規）	未整備	新規整備、本人・家族支援を実装
J-3	認知症カフェ・本人ミーティング	「喫茶みかん」継続・本人 M 未実施	カフェ継続＋本人ミーティング新設
J-4	早期発見・早期対応の体制強化	初期集中支援チーム稼働中	もの忘れ相談継続、支援チーム強化
J-5	国保川崎病院との医療連携	継続	認知症診断・治療・初期段階フォローの地域中核

KPI の 3 層構造（プロセス・アウトプット・アウトカム）

プロセス（活動量）	町・包括センター・地域での認知症施策の活動回数等	サポーター養成講座開催回数・カフェ開催回数
アウトプット（成果物）	活動の直接的な成果物・参加者数等	サポーター累計数（550 名→目標）、チームオレンジ整備
アウトカム（住民の変化）	住民の意識・行動・QoL の変化	認知症本人と家族の地域生活満足度（アンケート測定）

5 本日まで協議いただきたい事項（5 項目）

以下の 5 項目について、委員の皆様のご意見を頂戴し、計画素案 Ver.2.0 に反映させていただきます。

【協議事項 1】基本理念のサブタイトル付加について

第 9 期から継承する基本理念「住民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」に、認知症基本法対応のサブタイトル「～認知症になっても誰もが自分らしく暮らせる地域共生社会の実現～」を新たに付加することの是非。

【協議事項 2】基本目標 6（認知症施策）の新設と第 6 章独立章化について

認知症基本法対応として、第 9 期の 5 基本目標に「基本目標 6：認知症施策の総合的推進」を追加し、第 6 章として独立章化する方向性の是非。第 6 章では、基本法第 15 条～21 条の 7 基本的施策に対応した町施策体系を構築します。

【協議事項 3】移動支援 3 層構造の整理について

令和 7 年 3 月のタクシー助成終了後、社協・NPO 福祉移送／デマンドバス／町民バスの 3 制度に移行しました。アンケートで認知度の低さが確認された場合、第 10 期計画では 3 制度の整理・住民周知の強化を

重点施策（J-B）として明示する方向性の是非。所管調整（地域振興課・町民生活課・社協・NPO）の進め方も含めご意見をいただきます。

【協議事項4】 認知症施策の重点施策5本柱とKPI3層構造について

認知症施策の重点5本柱（J-1 サポーター拡大／J-2 チームオレンジ整備・新規／J-3 本人ミーティング新設／J-4 早期発見・体制強化／J-5 医療連携）の方向性。特にJ-2 チームオレンジとJ-3 本人ミーティングの新規取組の進め方、及びKPI3層構造（プロセス・アウトプット・アウトカム）の設定方針へのご意見をいただきます。

【協議事項5】 介護保険料試算3パターン（A/B/C）の検討方針について

第10期保険料は、介護給付費準備基金の取崩額により3パターン（A：取崩なし／B：50%取崩／C：全額取崩）を試算する方向性です。確定値は介護給付費準備基金残高（R8.6時点・現在確認中）の確定後、第3回策定委員会（R9.1中旬）で協議します。本日は方向性へのご意見をいただきます。また、所得段階区分の9段階から13段階への見直しの検討方針もあわせてご意見をいただきます。

以上5項目について、忌憚のないご意見を頂戴できますと幸いです。

本日の進行・次回以降のスケジュール

■ 第10期計画策定の今後のスケジュール

R8.8 中旬	第1回策定委員会（本日）	アンケート結果・骨子案協議事項5項目	骨子協議
R8.9-10	計画素案 Ver.2.0 更新	委員意見の反映、サービス見込量精緻化	素案更新
R8.11	第2回策定委員会	Ver.2.0 素案審議・サービス見込量方向性確定	素案審議
R8.12-R9.1	保険料試算精緻化	給付費・地域支援事業費・3パターン精緻化	試算精緻化
R9.1 中旬	第3回策定委員会	保険料3パターン協議・パターン選定	保険料協議
R9.2	第4回策定委員会・町長答申	保険料基準額決定・最終素案承認	基準額決定
R9.2-3	パブリックコメント・3月議会上程	住民意見募集・条例改正案上程	確定・公表

■ 別添資料一覧

①	川崎町_計画書素案_v1.5_カラー統一版.pdf (43 頁)	本骨子案の詳細版・参考資料
②	川崎町_アンケート集計分析テンプレート.xlsx	アンケート結果の詳細集計表
③	川崎町_第9期実績一覧_町記入用.xlsx	第9期実績の根拠データ
④	策定委員会 委員名簿	委員一覧（町担当課作成）
⑤	第10期計画策定スケジュール	全体スケジュール表

本日は貴重なお時間を頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。